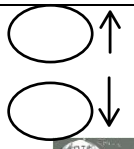
小结与串联：**遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）**：

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血）→遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂（遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）



在生理中(血沉与血浆成分有关):遗传球的血沉不变

二、白细胞



①巨噬细胞等→集落刺激因子 CSF→粒细胞↑

②T 细胞在胸腺成熟，参与细胞免疫

B细胞在骨髓成熟,参与体液免疫



三、血小板——保持血管内皮完整性

血小板是从骨髓成熟巨核细胞胞质裂解脱落下来的小块胞质（巨核细胞掉下来的渣渣）

需注意区分巨核细胞、巨噬细胞、单核细胞　巨核细胞 —裂解脱落掉下来的渣渣→ 血小板

单核细胞 —进入组织发育→ 巨噬细胞

1.**黏附：识别损伤部位**



①血栓形成最重要的原因是内皮细胞损伤（暴露内皮下胶原纤维）

②内皮细胞损伤后释放 **vWF**，作为**黏附的桥梁**。巨大血小板综合征（缺乏 GPIb 巨大才能做 1）、**血管性血友病（缺乏 vWF）**、胶原纤维变性影响黏附　血友病:凝血因子VIII,IX,XI异常 缺乏vWF→假性血友病

2.聚集　内皮细胞 —受损释放→ vWF → 提高8因子稳定性

①血小板与血小板之间相互黏着：需血小板糖蛋白 GPIIb/IIIa、Ca^{2+}、**纤维蛋白原（桥梁**网住血小板**）**。血小板无力症（GPIIb/IIIa 异常三心二意聚精无力）、缺乏纤维蛋白原影响聚集

②**抑制血小板聚集：NO、前列环素 PGI_2**

③促进血小板聚集（**致聚剂**）：ADP、TXA_2、5-HT、组胺、胶原、凝血酶、肾上腺素、病原微生物、免疫复合物、药物（记少不记多）